

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Transduodenal Sphincteroplasty

معلومات الإقرار – نسخة المريض
رأب العضلة العاصرة عبر الإثنا عشر

1. What is a transduodenal sphincteroplasty?

The procedure will open up the opening of the bile duct into the duodenum. This allows better drainage of bile into the gut.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and

1 ما هو رأب العضلة العاصرة عبر الإثنا عشر؟

في هذا الإجراء يتم شق الفتحة التي تطل بها القناة المرارية على الإثنا عشر، مما يسمح بتصريف أفضل لمادة الكبد الصفراء إلى الأمعاء.

2. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث انسداد للشعب الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- You may have difficulty passing urine after the operation and may need a catheter passed into the bladder.
- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery
- The opening of the duodenum to allow the operation on the exit of the bile duct may not heal properly and cause a leak of bowel fluid. This may require a period of IV feeding and rarely requires further surgery.
- The pancreas may become inflamed and this can cause a serious disease called acute pancreatitis.
- Damage may occur to the bile ducts which carry the bile from the liver to the gut. This can cause a narrowing which gives long term complications.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with distension of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness can occur in the wound with the development of a rupture or hernia.
- In some people healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red - a keloid scar and the scar may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- Increased risk in smokers of wound and chest

يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من الجلطة ليصل إلى الرئة.
• الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء:

- قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة ، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة .
- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- فتحة الإثنا عشر والتي تسمح بإجراء الجراحة على مخرج القناة المرارية قد لا تلتئم بشكل صحيح وتسبب تسرب لسوائل الأمعاء ، قد يتطلب ذلك بقاء المريض لفترة من الزمن على التغذية الوريدية ومن النادر أن يتطلب الأمر جراحة أخرى.
- قد يلتهم البنكرياس مما يسبب مرض خطير وهو التهاب البنكرياس.
- حدوث ضرر للقنوات المرارية التي تحمل المادة الصفراء من الكبد إلى الأمعاء . قد يسبب ذلك ضيقاً للقناة المرارية مسبباً مضاعفات طويلة الأمد .
- الإصابة بالتهاب سوائل البطن كتجمعات للصدى في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً .
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد أو ببطء الحركة بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ . قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- قد تصبح منطقة الجرح ضعيفة ويحدث فيها تمزق أو ينشأ فيها فتق .
- عند بعض المرضى ، قد يلتئم الجرح بشكل طبيعي . قد تزداد سماكته ويصبح لونه أحمر (ندب الجدة المتليف) ، وقد يكون الندب مؤلماً.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

● عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

أقوم أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
